# الأمراض الهضمية

2 د. باسل شوربا

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري



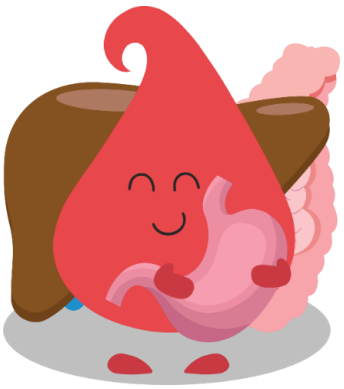
## السلام عليكم

نُقدم لكم المحاضرة الرابعة والأخيرة من قسم المهارات الهضمية، والتي سنُفصِّل فيها عن أهم الأمراض الهضمية ألا وهي الحبن واليرقان، مُفصلين فيها عن كيفية التعامل مع هذا المريض وكيفية التوجُّه إلى التشخيص السليم

-نأمل أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم-

## فهرس المحتويات

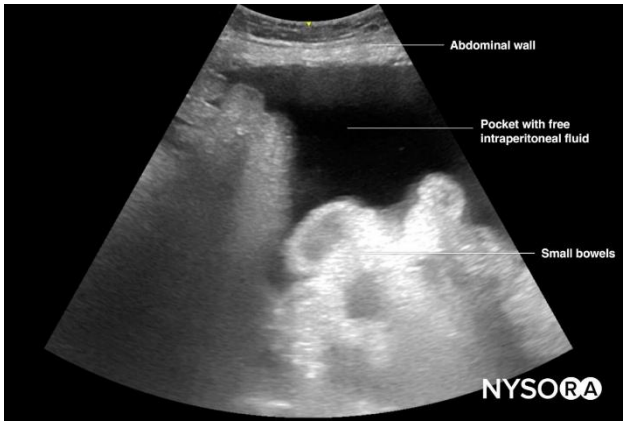

| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| الحبن | 2 |
| اليرقان | 6 |

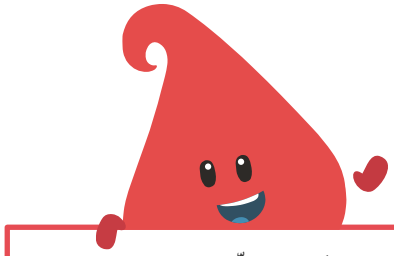



# الحبن Ascites

- **تعريفه**: هو نزوح سائل إلى جوف البريتوان بين وريقتيه الجدارية والحشوية.
  - في الحالة الطبيعية يوجد كميات قليلة من سائل مزلق بين وريقتي البريتوان.
- **آلية حدوث الحبن وأسبابه**: عندما تتأذى بطانة الأوعية الشعرية تسمح بتسريب السائل مع بروتينات المصل، فينزح السائل من هذه الأوعية إلى جوف البريتوان بطريقة إما التهابية أو ميكانيكية.

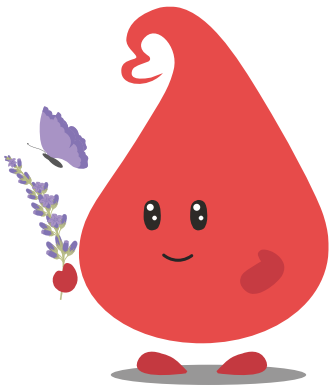
سائل الحبن قد يكون مصلي أو ورمي أو قيحي أو دموي حسب العامل المسبب.



صورة إيكو توضّح وجود سائل حر في التجويف البريتواني

| الحبن: هو نزوح سائل من الأوعية الشعرية إلى جوف البريتوان بإحدى الآليتين.. | | |
|---|---|---|
| آلية حدوثه | الآلية الميكانيكية | الآلية الالتهابية |
| السبب | عامل ميكانيكي هو ازدياد الضغط ضمن الأوعية | عامل التهابي هو سل أو سرطان أو انثقاب حشا أجوف أو التهاب زائدة دودية أو التهاب مرارة شديد أو أي خمج آخر |
| النتيجة | مهما كان سبب ازدياد الضغط داخل الوعاء، تتوسع بطانة الوعاء ويخرج كميات كبيرة من السائل حاملاً معه كميات قليلة من البروتين (الألبومين) إلى جوف البريتوان | يسبب الالتهاب تخريش لخلايا الأوعية الشعرية البطانية بالتالي تسمح بمرور كميات كبيرة من السائل والبروتين (الألبومين) على حد سواء |
| اسم الحبن | الحبن الرشحي أو النتعي (نتعي تشير إلى الكميات القليلة للألبومين بالسائل الراشح) | الحبن النتحي |



## ↙ أسباب ازدياد الضغط داخل الأوعية (بالآلية الميكانيكية للحبن):

### 1. فرط توتر وريد الباب:

- بسبب تشمع (تليف) الكبد فإن الدم المحمول في وريد الباب يواجه عائقاً عندما يصل إلى الكبد فيعود أدراجه مسبباً ارتفاع الضغط داخل الوريد ونزوح السائل حاملاً معه القليل من الألبومين أي حبن نتعي.

### 2. قصور قلب أيمن احتقاني:

- يزداد ضغط الدم المتجه إلى القلب الأيمن ويحتقن في الأوردة ويتجمع في الكبد (لأن الكبد هو محطة الدم الرئيسية قبل القلب) فيسبب ارتفاع توتر وريد الباب أيضاً وبالتالي حبن نتعي.

### 3. التناذر النفروزي:

- يحدث فيه رشح للبروتينات في البول بسبب أذية كلوية مما يؤدي لنقصان الألبومين في الأوعية وبالتالي نتع السوائل باتجاه أجواف البطن والجنب والتامور.

## الاستجواب والقصة السريرية لمريض الحبن

☑ للحبن عدة أسباب أهمها هي: **تشمع الكبد**، **السرطانات**، **السل**؛ لذلك عند استجواب مريض مصاب بالحبن نتوجه بالأسئلة إلى أعراض هذه الأمراض.

90% من حالات الحبن هي بسبب تشمّع الكبد، و10% بالأسباب الأخرى.

### 1. الكبد:

- نسأل عن إصابات سابقة بالتهاب الكبد، قصة تشمع كبد.
  - ↳ **علامات التشمع:** هي راحة حمراء، أظافر بيضاء، دوران جانبي، ضخامة طحال.
- نسأل عن قصص نقل دم.
- نتحرى ترافق الحبن مع أعراض أخرى مثل إقياءات دموية أو تغوط دموي (لأنها تشير إلى فرط توتر وريد الباب وتشمع الكبد).

### 2. السرطانات:

- نسأل عن التعب والوهن العام، نقص الشهية، فقدان الوزن.
- نسأل عن قصة سرطان قديم (مثلاً مريض شخص بسرطان كولون واستأصله منذ عام، يأتي الآن بشكاية ضخامة بطن، نتأكد بالإيكو أنه حبن، إذا المريض يعاني حبن ناتج عن انتقالات سرطانية).

### 3. السل:

- سوابق مرضية بالسل الرئوي، وجود ارتفاع حرارة أو تعرق ليلي.

### 4. تحري الأسباب الأخرى: مثل قصور القلب والتناذر النفروزي.

## كشف الحبن سريرياً

☑ لا نستطيع كشف الحبن سريرياً إلا إذا كانت كميته كبيرة أو متوسطة، أما الحبن قليل الكمية فلا يظهر إلا بالإيكو.

### التأمل:

» **كبر حجم كل البطن وزوال الثنيات حول السرة** بسبب تمدد وتوتر البطن.

### القرع:

» **الحبن كبير الكمية**: القرع **أصمي شامل**.

» **الحبن متوسط الكمية**: بالقرع نجد علامة **الأصمية المتنقلة** إيجابية.

» **الحبن قليل الكمية**: نكشف عنه **بالايكو**.

قد تغيب علامة الأصمية المتنقلة عند وجود التصاقات تالية لعمليات جراحية على البطن وعندها نجد أصمية موضعة في أماكن معينة.

### الجس:

#### 1. علامة قطع الثلج:

- تكون إيجابية عندما يترافق الحبن مع اعضاء متضخمة في البطن.
- عندما نضغط على الكتلة بيدنا فإنها تغوص للداخل ثم بعد ثوان نحس بأنها عادت وارتطمت بيدنا، نسمي هذه العلامة بعلامة قطعة الثلج وهي **إيجابية** في **الحبن** وفي **ضخامة الكبد والطحال والكلية**.

#### 2. علامة التموج:

- نضع فيها يدنا اليسرى على بطن المريض المستلقي ونضع يدنا اليمنى على يمين بطن المصاب، ثم نطلب من أحد ما أن يضرب على بطن المريض من الناحية اليسرى فنشعر بالموجة الآتية من الناحية اليسرى إلى الناحية اليمنى والتي هي موضع يدنا اليمنى.

### 3. المس الشرجي:

- نلاحظ **تقبباً في رتج دوغلاس** (الوجه الأمامي للشرج) مترافقاً مع الحبن.

### 4. المس المهبلي:

- نلاحظ **تقبباً في الرتج المهبلي وهبوط في الرحم وتحركه مع عنق الرحم** نحو الأسفل.

## الفحوص المتممة

### بزل الحبن:

» يتم **بزل الحبن** في **نقطة ماك بورني اليسرى**[1] (لبعدها عن الأحشاء المهمة).

» يتم **استقصاء الـ SAAG**[2] **في سائل الحبن المبزول**؛ حيث نحسب قيمة الـ SAAG من المعادلة التالية:

ممال الألبومين في الحبن SAAG = ألبومين المصل – ألبومين سائل الحبن

### 1. إذا كانت النتيجة أكبر أو يساوي 1.1 غ/100 مل:

- الألبومين في السائل المبزول **قليل** بالتالي **حالة ميكانيكية** ناتجة عن تشمع كبد أو قصور قلب أو تناذر نفروزي والتمييز بين تلك الأمراض سهل لأن لكل منها أعراض واضحة ومستقلة.

### 2. إذا كانت النتيجة أقل من 1.1 غ/100 مل:

- الألبومين في السائل المبزول **كثير** بالتالي **حالة التهابية** ناتجة عن التهاب بريتوان أو سل أو سرطان.

### الدراسة الخلوية الجرثومية:

» نتحرى كمية الكريات البيض: إذا زادت على حساب **اللمفاويات** ← **السل**، أما إذا زادت على حساب **العدلات** ← **التهاب بريتوان**.

### وجود خلايا ورمية:

» إيجابية توجه للسرطان، السلبية الكاذبة شائعة وبالتالي لا تنفي.

### تحري وجود عصية كوخ (عصية السل).

### تنظير البطن التشخيصي مع الخزعات.

[1] تذكّر: نقطة ماك بورني: تصل بين السرة والشوك الحرقفي الأمامي العلوي بخط فتقع ماك بورني عند التقاء الثلثين الإنسيين مع الثلث الوحشي.

[2] ممال الألبومين في الحبن Serum Ascites Albumin Gradient.

## التشخيص التفريقي

☑ **البدانة**؛ توجد ثنيات حول السرة، قرع طبلي، **علامة التموج سلبية**.

☑ **تطبل البطن**، **الكرة المثانية**، **كيسة مبيض عرطلة**.

## اليرقان Jaundice

◄ هو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر، يحدث بسبب ارتفاع نسبة البيلروبين المباشر وغير المباشر في الدم.

### ↙ مقارنة بين البيلروبين المباشر وغير المباشر:

| البيليروبين غير مباشر | البيلروبين المباشر |
|---|---|
| ينتج عن تحلل الكريات الحمراء | ينتج عن اقتران البيليروبين غير المباشر بوساطة خميرة غلوكورونيل ترانسفيراز |
| • غير منحل بالماء وبالتالي لا يطرح عن طريق الكلية.<br>• ينحل في الدسم ويعبر الحاجز الدماغي ليصل إلى النوى القاعدية وبالتالي اليرقان النووي (اعتلال عصبي). | يصبح منحل بالماء ويطرح عن طريق الكبد في العصارة الكبدية الصفراوية |

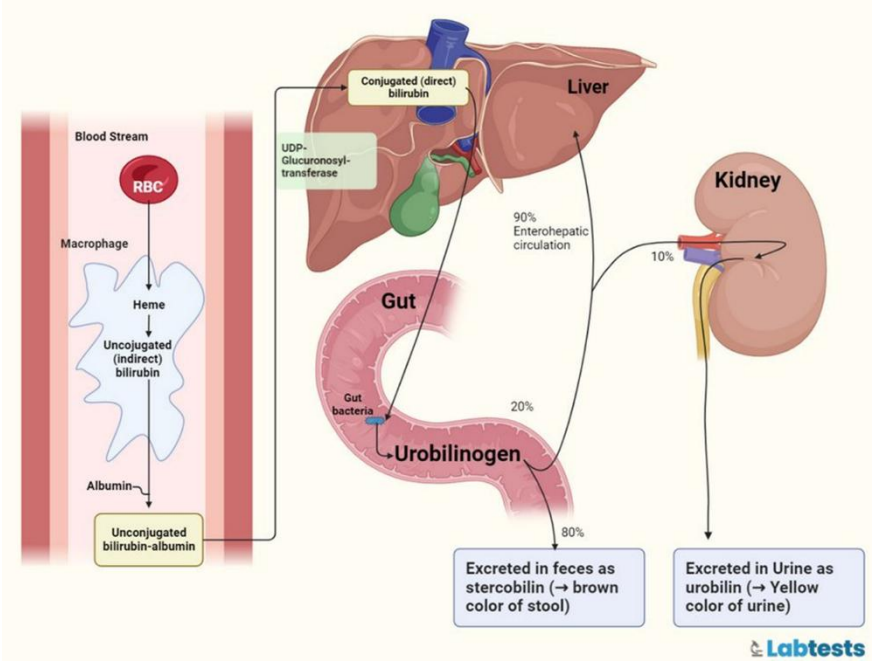
مخطط تفصيلي يوضّح عملية استقلاب البيليروبين في الجسم[3]

✍ الكريات الحمراء ← هيم ← بيليروبين غير مقترن.

✍ في الكبد: البيليروبين غير المقترن ← بيليروبين مقترن.

✍ في الأمعاء: البيليروبين المقترن ← يوروبيلينوجين.

✍ يُعاد امتصاص 90% من اليوروبيلينوجين إلى الدم، ويُطرح 10% في البول على هيئة يوروبيلين.




[3] ورد المخطط في سلايدات الدكتور بدون أي شرح، وما ذكر من شرح هو توضيح من الفريق.

## اليرقان على حساب البيلروبين غير المباشر

### 1. فقر الدم الانحلالي.

### 2. داء جيلبيرت (وراثي):

- يتظاهر بنقص في خميرة الغلوكورونيل ترانسفيراز في الكبد.
- يؤدي نقص الخميرة إلى بقاء كميات من البيليروبين غير المباشر دون ارتباط، هذه الكميات ستعود إلى الدم.
- وعند بذل أي جهد (صيام/تعب) سترتفع نسبة البيليروبين غير المباشر وتظهر أعراض اليرقان (اصفرار الصلبة والوجه عند التعب)، ويكون معزول.

### 3. يرقان فيزيولوجي:

- يبدأ بعد اليوم الأول من الولادة ويمكن أن يستمر مدة 16 يوم.

## يرقان على حساب البيليروبين المباشر

### 1. أذية الخلية الكبدية (التهاب أو تورم أو تشمع).

### 2. وجود عائق في الأقنية الصفراوية (يرقان انسدادي).

#### أعراض اليرقان:

- براز أبيض حواري، لون بول أحمر بني (غامق)، حكة جلدية، إسهال دهني.

#### درجات اليرقان:

- **اللون تحت اليرقاني**: بيليروبين 1.5 إلى 3 ملغ/100مل.
- **يرقان صريح**: بيليروبين المصل أكثر من 3 ملغ/100مل.
- **يرقان شديد جداً**: بيليروبين المصل أكثر من 30 وغالباً على حساب غير المباشر.

تذكرة: القيمة الطبيعية للبيليروبين الكلّي 0.2 – 1.2 ملغ/100مل. EXTRA

# الفحوص المتممة

## 1. فحص الدم لتعرف نوع البيليروبين وحسب النتيجة:

- إذا كان البيليروبين المسبب لليرقان هو **غير مباشر** ← فالمشكلة دموية.

  ↳ نطلب استقصاءات دموية لتحري وجود انحلال دم (فقر دم مع ارتفاع الشبكيات) أو داء جيلبرت.
- إذا كان البيليروبين المسبب لليرقان هو **المباشر** ← فالمشكلة كبدية أو بالطرق الصفراوية، نلجأ للإيكو.

## 2. إيكو عندما يكون الارتفاع على حساب البيليروبين المباشر وحسب النتيجة:

- إذا كان الإيكو **طبيعي** ← فالإصابة داخل الكبد (تشمع /التهاب/ وراثي "دوبن جونسون").
- إذا أظهر الإيكو **توسع بالطرق الصفراوية** ← يشير ذلك إلى وجود عائق فيها قد يظهره الإيكو.

في حال بقي التشخيص مبهماً (الإيكو طبيعي ولم نعرف الاصابة داخل الكبد أم العائق في الطرق الصفراوية (نلجأ للطبقي المحوري أو ERCP أو ال MRCP.

**نصل معكم إلى ختام محاضرتنا**

**وختام قسم الهضمية ^_^**

-لا تنسونا من الدعاء-

